

■ 制度・行政

「生成AIでリハビリサマリ作成」が厚労省の概算要求に

国立病院機構の69施設にAI・ICT機器、新規30億円

厚労省医政局の令和9年度概算要求（主要事項、35ページ）に「医療現場におけるAI技術等を活用した業務効率化事業」が新規で入った。要求額は30億円。令和7年度補正予算で15億円の先行事業があり、9月9日の第2回ヘルスケアAX・DX推進本部でも示された内容だ。

仕組みは、補正予算で国立病院機構（NHO）の

病院に入れたICT機器等を部門ごとに「導入前後のタイムスタディ」で効果検証し、効いたものをセーフティネット分野の69病院と附属看護学校21施設へ横展開する。導入機器のイメージには、生成AI（会議録・看護サマリ・リハビリサマリ作成）、搬送ロボット、電子カルテの音声入力とモバ

イル参照、全自動薬剤分包機が並ぶ。

国内の病院報告では、リハサマリ作成にAIを入れて作業時間は23分から10分に縮んだが、エラーは8割にあった。今回の物差しは時間で、中身の精度を誰がどう測るかは、資料にまだ書かれていない。



リハ室の記録が自動で組み上がる。物差しは「時間」

出典 **厚生労働省 医政局**
『令和9年度概算要求
主要事項』 [➤](#)

数字で見る

30 億円
新規要求額

69 施設
国立病院機構

R9 年度
概算要求

■ 心臓リハ／RCT

フレイル患者の心臓手術前リハ SPPBは約1点改善、再入院は差なし

香港大学のパイロット RCT（Eur J Cardiovasc Nurs）。待機的な冠動脈・弁手術を予定する軽度～中等度フレイルの成人を、介入26人と通常ケア25人に分けた。介入は教育、栄養最適化、ストレス管理、レジスタンス中心の個別運動を4週間以上。

主要評価のSPPBは術前日に $\beta=0.99$ 、3か月後に $\beta=1.04$ と介入群が高く、Friedのフレイルも低



下。遵守率89%。一方で臨床イベント、予定外再入院、在院日数には有意差なし。著者ら自身が「本試験が必要」とする段階だ。

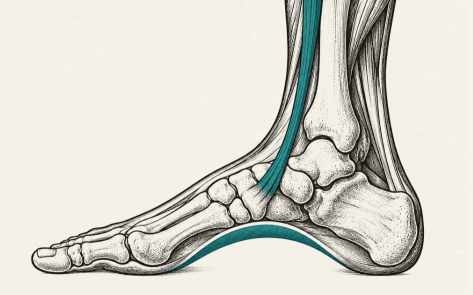
出典 **Eur J Cardiovasc Nurs**
(PubMed) [➤](#)

■ 運動器／基礎研究

前脛骨筋の電気刺激だけで内側縦アーチが挙上

藤田医科大学のグループがPLOS Oneに報告。健康成人25人の前脛骨筋を、背屈が見えない強度の電気刺激で収縮させ、舟状骨上の加速度計と母趾・足関節のゴニオメータで測った。

舟状骨は上方・後方・内側へ変位し、上方変位は25人全員で確認。母趾は平均1.36°内反（24人で変化）。舟状骨の上方変位が大きいほど母趾の内反



も大きい（ $r=0.463$ ）。「腱のあぶみ」に初の直接証拠だが、健康若年者の単回刺激で、外反母趾が改善したわけではない。

出典 **PLOS One**
(PubMed) [➤](#)

短 信

〈制度〉介護報酬改定、関係団体ヒアリング始まる

第1回は介護系居宅サービスが対象で、通所介護の送迎介助時間の算入や生産性向上加算が要望に。リハ専門職団体協議会は第2回に参加予定。 出典 PT-OT-ST.NET [➤](#)

〈呼吸リハ〉肺移植後の呼吸リハ、6分間歩行171m延長

メディケア型36回の外来リハ、367人。修了者の6分間歩行は中央値171m（61%）延び、開始時に長いほど伸びは小さい。移植前の重症度は無関係。 出典 Annals ATS [➤](#)

〈医療AI〉リハ職のAI導入、意向は高く準備は中程度

国際調査2,496人。利用意向は高いが準備度は中程度で、意向は成果期待・自己効力・不安・年齢・職種と関連。導入が育成より速いと結論。 出典 Disabil Rehabil [➤](#)

〈呼吸リハ〉間質性肺疾患のHIIT、中強度運動と差なし

線維化性ILD131人、8週の呼吸リハでHIITと中強度持続運動を比較。持久時間（MD-63秒）も6分間歩行（4m）も差なし。有害事象なし。 出典 AJRCCM [➤](#)

〈心血管〉心血管疾患のサルコペニアに運動と栄養

欧州予防心臓病学会の声明。持久運動にレジスタンス運動を加え、十分な蛋白で低栄養を避ける。ただし心血管疾患での質の高い証拠は不足と明記。 出典 Eur J Prev Cardiol [➤](#)

〈教育〉医療系学生、実習中の生成AI利用52.6%

仏388名（医・薬・看護・助産・PT）。利用率52.6%、用途は情報検索77.9%が最多。患者の識別情報を入力した経験も23.5%あった。 出典 リハロジPT note（原著 JMIR Med Educ） [➤](#)

〈患者教育〉LLM支援の患者教育、17か国48研究を統合

17か国48研究の混合法SR。理解と情報面の改善は一貫するが、満足・信頼・共感・行動変容の証拠は混在か不足。医療者との対話の補助と位置づけ。 出典 npj Digital Medicine [➤](#)

〈薬剤〉高齢者のスタチン、障害なし生存は延びず

豪州の70歳以上9,971人、アトルバスタチンとプラセボのRCT（中央値5.9年）。心血管イベントはHR0.70で減少、死亡・認知症・障害の複合はHR0.94で差なし。 出典 NEJM [➤](#)